



www.ispits.net

QCM3/2017

QCM CORRIGÉ

Séance animée par: Mr HADDOUGUI Driss: Chef
de PSI CHP Mohammedia
Le Jeudi 5/10/2017

I-L'ÉVALUATION:

A-Est une technique dont l'objectif est de porter un jugement de valeur

B- Se base sur des critères et des normes

C- N'implique pas la mesure de l'adéquation, de l'efficacité et du rendement des services de sante

D-Aide à redistribuer les priorités et les ressources en fonction de l'évolution des besoins

I-L'ÉVALUATION:

A-Est une technique dont l'objectif est de porter un jugement de valeur

B- Se base sur des critères et des normes

C- N'implique pas la mesure de l'adéquation, de l'efficacité et du rendement des services de sante

D-Aide à redistribuer les priorités et les ressources en fonction de l'évolution des besoins

2-LA QUALITÉ C'EST:

- A. La mesure des écarts constatés entre prévisions et réalisations
- B. L'aptitude d'un produit ou d'un service à satisfaire les besoins des utilisateurs
- C. Un plan d'action
- D. Une évaluation finale des objectifs

2-LA QUALITÉ C'EST:

- A. La mesure des écarts constatés entre prévisions et réalisations
- B. L'aptitude d'un produit ou d'un service à satisfaire les besoins des utilisateurs
- C. Un plan d'action
- D. Une évaluation finale des objectifs

3-L'ÉVALUATION DES PRESTATIONS DE SANTÉ:

- A- Permet l'appréciation du degré de réalisation des objectifs sanitaires
- B- Se réalise toujours au terme des prestations
- C. Repose sur des critères fondés sur les normes
- D. Implique que le bénéficiaire des prestations n'est pas nécessairement concerné.

3-L'ÉVALUATION DES PRESTATIONS DE SANTÉ:

- A- Permet l'appréciation du degré de réalisation des objectifs sanitaires
- B- Se réalise toujours au terme des prestations
- C. Repose sur des critères fondés sur les normes
- D. Implique que le bénéficiaire des prestations n'est pas nécessairement concerné.

4-L'ÉVALUATION DU PREMIER NIVEAU :

- A. Vérifie si les tâches sont exécutées
- B. Les réponses sont de type « oui / non » ou « fait / non fait ».
- C. Précise le niveau de qualité des tâches exécutées.
- D. les réponses sont de type « excellent, bon, moyen, médiocre » ou exprimées par des scores « 1,2,3,4 »

4-L'ÉVALUATION DU PREMIER NIVEAU :

- A. Vérifie si les tâches sont exécutées
- B. Les réponses sont de type « oui / non » ou « fait / non fait ».
- C. Précise le niveau de qualité des tâches exécutées.
- D. les réponses sont de type « excellent, bon, moyen, médiocre » ou exprimées par des scores « 1,2,3,4 »

5-L'EFFICACITÉ EST :

www.ispits.net

- A. Le rapport qui existe entre les effets obtenus par une activité ou un programme et objectifs qui leur ont été fixés.
- B. Le rapport qui existe entre le coût engagé pour une action et les effets que celle – ci produit en termes d'efficacité.

5-L'EFFICACITÉ EST :

- A. Le rapport qui existe entre les effets obtenus par une activité ou un programme et objectifs qui leur ont été fixés.
- B. Le rapport qui existe entre le coût engagé pour une action et les effets que celle – ci produit en termes d'efficacité.

6-La méthodologie d'évaluation d'une prestation répond au processus chronologique suivant:

- A- Le recueil des données, la description de la pratique idéale, l'analyse des données, la corrections des écarts
- B- la description de la pratique idéale, Le recueil des données , l'analyse des données
- C. la description de la pratique idéale, Le recueil des données , l'analyse des données, la corrections des écarts
- D. Le recueil des données , l'analyse des données, la corrections des écarts

6-La méthodologie d'évaluation d'une prestation répond au processus chronologique suivant:

A- Le recueil des données, la description de la pratique idéale, l'analyse des données, la corrections des écarts

B- la description de la pratique idéale, Le recueil des données , l'analyse des données

C. la description de la pratique idéale, Le recueil des données , l'analyse des données, la corrections des écarts

D. Le recueil des données , l'analyse des données, la corrections des écarts

7-L'ÉVALUATION DE LA QUALITÉ :

- A. Est la mesure de l'écart entre une situation réelle et une situation considérée comme optimale telle qu'elle est décrite par l'instrument de mesure.
- B. Consiste à déterminer l'importance de l'écart observé et à l'interpréter.
- C. Outil d'aide à la prise de décision.
- D. Une activité ponctuelle.

7-L'ÉVALUATION DE LA QUALITÉ :

- A. Est la mesure de l'écart entre une situation réelle et une situation considérée comme optimale telle qu'elle est décrite par l'instrument de mesure.
- B. Consiste à déterminer l'importance de l'écart observé et à l'interpréter.
- C. Outil d'aide à la prise de décision.
- D. Une activité ponctuelle.

8- Vous êtes sollicité pour préparer les éléments nécessaires à la réussite de l'évaluation des activités sanitaires. Quand est ce que l'évaluation n'est pas recommandée:

- A- Lorsqu'on a besoins de réadapter des activités sanitaires
- B- Lorsqu'une activité sanitaire est extrêmement populaire, accompagnée de problèmes techniques
- C- Lorsque certaines modifications apportées au programme risquent de comporter des dangers
- D- Lorsque l'on veut apprécier le degré de réalisation des objectifs

8- Vous êtes sollicité pour préparer les éléments nécessaires à la réussite de l'évaluation des activités sanitaires. Quand est ce que l'évaluation n'est pas recommandée:

A- Lorsqu'on a besoins de réadapter des activités sanitaires

B- Lorsqu'une activité sanitaire est extrêmement populaire, accompagnée de problèmes techniques

C- Lorsque certaines modifications apportées au programme risquent de comporter des dangers

D- Lorsque l'on veut apprécier le degré de réalisation des objectifs

9-Quelles sont parmi les propositions suivantes celles qui sont justes:

- A- L'indicateur de structure renseigne sur les moyens et ressources utilisés
- B- L'indicateur de processus renseigne sur l'atteinte des objectifs fixés
- C- L'indicateur de satisfaction renseigne sur le niveau de qualité perçue
- D- L'indicateur de résultat renseigne sur les activités au service d'un objectif

9-Quelles sont parmi les propositions suivantes celles qui sont justes:

- A- L'indicateur de structure renseigne sur les moyens et ressources utilisés
- B- L'indicateur de processus renseigne sur l'atteinte des objectifs fixés
- C- L'indicateur de satisfaction renseigne sur le niveau de qualité perçue
- D- L'indicateur de résultat renseigne sur les activités au service d'un objectif

I0-L'évaluation des prestations de soins est basée sur des normes et des critères. Parmi les normes citées ci-dessous, quelle(s) est/sont celle(s) en rapport avec la PEC du patient?

- A- La répartition quotidienne du personnel est équitable selon la charge de travail
- B- La programmation des soins est révisée régulièrement selon la prescription médicale
- C. Une secrétaire hospitalière (médicale) est présente parmi le staff du personnel soignant
- D. L'approvisionnement en médicaments urgents est assuré en dehors des heures ouvrables de la pharmacie.

I0-L'évaluation des prestations de soins est basée sur des normes et des critères. Parmi les normes citées ci-dessous, quelle(s) est/sont celle(s) en rapport avec la PEC du patient?

A- La répartition quotidienne du personnel est équitable selon la charge de travail

B- La programmation des soins est révisée régulièrement selon la prescription médicale

C. Une secrétaire hospitalière (médicale) est présente parmi le staff du personnel soignant

D. L'approvisionnement en médicaments urgents est assuré en dehors des heures ouvrables de la pharmacie.

II - Parmi ces indicateurs, quels sont ceux en rapport avec l'activité hospitalière:

A-Taux d'occupation moyenne

B-Nombre de malades dialysés

C-Nombre de décès intra hospitaliers

D-Durée moyenne de séjour

II - Parmi ces indicateurs, quels sont ceux en rapport avec l'activité hospitalière:

A-Taux d'occupation moyenne

B-Nombre de malades dialysés

C-Nombre de décès intra hospitaliers

D-Durée moyenne de séjour

I 2-Les indicateurs de résultats immédiats portent sur :

- A- la notion d'équité
- B- La notion d'efficacité
- C. La notion de productivité
- D. La notion de couts visibles et cachés

I 2-Les indicateurs de résultats immédiats portent sur :

A- la notion d'équité

B- La notion d'efficacité

C. La notion de productivité

D. La notion de couts visibles et cachés

I 3-Quels sont les paramètres utilisés pour évaluer un programme de santé:

- A- indicateur de performance
- B- indicateur d'impact
- C. Entretien avec le personnel
- D. l'enquête auprès des usagers

I 3-Quels sont les paramètres utilisés pour évaluer un programme de santé:

www.ispits.net

A- indicateur de performance

B- indicateur d'impact

C. Entretien avec le personnel ????

D. l'enquête auprès des usagers

I 4-Les composantes de l'évaluation des services de santé comprennent:

- A- le rendement du personnel et la présence du personnel
- B- la qualité des prestations fournies
- C. La disponibilité du matériel
- D. Le nombre des prestations réalisées

14-Les composantes de l'évaluation des services de santé comprennent:

A- le rendement du personnel et la présence du personnel???????

B- la qualité des prestations fournies

C. La disponibilité du matériel

D. Le nombre des prestations réalisées

I 5-La démarche d'évaluation des pratiques professionnelles :

- A- Vise à réduire les pratiques non adaptées aux besoins du patient ainsi que leur conséquences
- B- Est basée sur les recommandations des bailleurs de fonds
- C- Permet de garantir des soins efficaces, efficients, surs, conformes aux données actuelles de la science
- D- Renseigne sur le degré de performance de l'unité de soins.

I 5-La démarche d'évaluation des pratiques professionnelles :

- A- Vise à réduire les pratiques non adaptées aux besoins du patient ainsi que leur conséquences
- B- Est basée sur les recommandations des bailleurs de fonds
- C- Permet de garantir des soins efficaces, efficients, surs, conformes aux données actuelles de la science
- D- Renseigne sur le degré de performance de l'unité de soins.

I 6-Dans le domaine de la santé , l'évaluation quantitative :

- A- Est fondée sur l'évaluation de l'utilité d'un acte de soins
- B- Est une analyse comparative d'actions alternatives en terme de couts et de conséquences sur la santé
- C. Est une analyse comparative d'actions alternatives en terme de couts uniquement
- D. Interagit avec l'évaluation de la qualité des soins

16-Dans le domaine de la santé , l'évaluation quantitative :

A- Est fondée sur l'évaluation de l'utilité d'un acte de soins

B- Est une analyse comparative d'actions alternatives en terme de couts et de conséquences sur la santé

C. Est une analyse comparative d'actions alternatives en terme de couts uniquement

D. Interagit avec l'évaluation de la qualité des soins

17-Les éléments essentiels pour l'élaboration d'un plan d'action pour la mise en œuvre des activités sanitaires sont :

A- Les objectifs, les stratégies, les ressources et les indicateurs d'évaluation

B- Les besoins, les ressources, et les méthodes d'évaluation

C. La vision, les stratégies, les ressources et les critères de performance

D. Les stratégies, les ressources, l'évaluation et le suivi

17-Les éléments essentiels pour l'élaboration d'un plan d'action pour la mise en œuvre des activités sanitaires sont :

A- Les objectifs, les stratégies, les ressources et les indicateurs d'évaluation

B- Les besoins, les ressources, et les méthodes d'évaluation

C. La vision, les stratégies, les ressources et les critères de performance

D. Les stratégies, les ressources, l'évaluation et le suivi

18-Le coût intangible est :

- A. Coût qui ne varie pas avec la quantité produite à court terme ;
- B. Coût qui varie en fonction de la quantité produite ;
- C. Valeur des biens et service pouvant être directement imputés à la production d'une prestation ;
- D. Psychologique concernant les pertes d'activités domestiques et la perte d'activités de loisir.

18-Le coût intangible est :

- A. Coût qui ne varie pas avec la quantité produite à court terme ;
- B. Coût qui varie en fonction de la quantité produite ;
- C. Valeur des biens et service pouvant être directement imputés à la production d'une prestation ;
- D. Psychologique concernant les pertes d'activités domestiques et la perte d'activités de loisir.

19-Le coût d'amortissement est :

- A. Ressources nécessaires pour créer ou étendre une capacité de production (Bâtiments, achat d'équipement, formation initiale de personnel) ;
- B. Constituent les ressources qui sont à renouveler chaque année (Personnel, fournitures, médicaments, entretien, formation régulière) ;
- C. Correspondent à la dépréciation des investissements ou dépenses en capital.

19-Le coût d'amortissement est :

- A. Ressources nécessaires pour créer ou étendre une capacité de production (Bâtiments, achat d'équipement, formation initiale de personnel) ;
- B. Constituent les ressources qui sont à renouveler chaque année (Personnel, fournitures, médicaments, entretien, formation régulière) ;
- C. Correspondent à la dépréciation des investissements ou dépenses en capital.

20-COÛT INDIRECT :

- A. Valeur des biens et services pouvant être directement imputés à la production d'une prestation.
- B. Valeur des conséquences liées à un phénomène, une action ou un programme (pertes de production de l'individu malade incapable de travailler).

20-COÛT INDIRECT :

- A. Valeur des biens et services pouvant être directement imputés à la production d'une prestation.
- B. Valeur des conséquences liées à un phénomène, une action ou un programme (pertes de production de l'individu malade incapable de travailler).

21-Le coût fixe :

- A. Ne varie pas avec la quantité produite à court terme.
- B. Varie en fonction de la quantité produite.

21-Le coût fixe :

- A. Ne varie pas avec la quantité produite à court terme.
- B. Varie en fonction de la quantité produite.

22-Coût d'investissement :

- A. Ressources nécessaires pour créer ou étendre une capacité de production (Bâtiments, achat d'équipement, formation initiale de personnel).
- B. Constituent les ressources qui sont à renouveler chaque année (Personnel, fournitures, médicaments, entretien, formation régulière).
- C. Correspondent à la dépréciation des investissements ou dépenses en capital.

22-Coût d'investissement :

- A. Ressources nécessaires pour créer ou étendre une capacité de production (Bâtiments, achat d'équipement, formation initiale de personnel).
- B. Constituent les ressources qui sont à renouveler chaque année (Personnel, fournitures, médicaments, entretien, formation régulière).
- C. Correspondent à la dépréciation des investissements ou dépenses en capital.

23-Parmi les exemples ci-dessous, quels sont les exemples de coûts directs ?

- A.** Les médicaments
- B.** Les frais de déplacement des patients
- C.** Les pertes de productivité
- D.** Les frais d'hospitalisation

23-Parmi les exemples ci-dessous, quels sont les exemples de coûts directs ?

- A. Les médicaments
- B. Les frais de déplacement des patients
- C. Les pertes de productivité
- D. Les frais d'hospitalisation

24-Une analyse coût-efficacité mesure les résultats obtenus en matière de santé en termes d'unités naturelles (par ex., Cas de VIH évités).

A. Vrai

B. Faux

24-Une analyse coût-efficacité mesure les résultats obtenus en matière de santé en termes d'unités naturelles (par ex., Cas de VIH évités).

A. Vrai

B. Faux

25-Les Études Cout-bénéfice Relient Les Couts D'une Action Médicale À Ses Conséquences Exprimées En Unités Physiques (Ex Années De Vies Gagnées, Nombre De Malades Évités) :

A. Vrai

B. Faux

25-Les Études Cout-bénéfice Relient Les Couts D'une Action Médicale À Ses Conséquences Exprimées En Unités Physiques (Ex Années De Vies Gagnées, Nombre De Malades Évités) :

A. Vrai

www.ispits.net

B. Faux

Il s'agit d'une étude cout-efficacité, les études cout-bénéfice comparent les couts et les bénéfices tout deux exprimés en unité monétaire.

26-L'équité horizontale vise la réduction de l'impact financier sur les groupes défavorisés

A. Vrai

B. Faux

26-L'équité horizontale vise la réduction de l'impact financier sur les groupes défavorisés

A. Vrai

B. Faux

L'équité horizontale vise la réduction du gradient social

27-L'équité verticale vise la réduction du gradient social

A. Vrai

B. Faux

27-L'équité verticale vise la réduction du gradient social

A. Vrai

B. Faux

L'équité verticale vise la réduction de l'impact financier sur les groupes défavorisés

28-La macro-économie en santé analyse les comportements au niveau d'entités individuelles (médecins, patients, ...)

A. Vrai

B. Faux

28-La macro-économie en santé analyse les comportements au niveau d'entités individuelles (médecins, patients, ...)

A. Vrai

B. Faux

Macro-économie: C'est une approche fondée sur la compréhension des phénomènes économiques considérés globalement. Elle s'intéresse au revenu national, aux investissements et à la consommation, à l'emploi, à la masse

29-Les établissements de santé sont organisés et gérés en vu de respecter:

- A. Les normes de sécurité des patients
- B. Les capacités de paiement des patients
- C. Les droits fondamentaux des patients
- D. Les règles des bonnes pratiques cliniques

29-Les établissements de santé sont organisés et gérés en vu de respecter:

- A. Les normes de sécurité des patients
- B. Les capacités de paiement des patients
- C. Les droits fondamentaux des patients
- D. Les règles des bonnes pratiques cliniques

30-La bonne gouvernance du système de santé passe par la focalisation sur:

- A. Les mécanismes administratifs
- B. Les mécanismes d'incitation
- C. Les mécanismes de contrôle
- D. Les mécanismes de participation
- E. Les mécanismes de transparence

30-La bonne gouvernance du système de santé passe par la focalisation sur:

- A. Les mécanismes administratifs
- B. Les mécanismes d'incitation
- C. Les mécanismes de contrôle
- D. Les mécanismes de participation
- E. Les mécanismes de transparence

Extrait du livre blanc

- Passer d'un mode d'exercice de l'autorité sanitaire commandé et contrôlé par le haut vers *un mode de régulation et de négociation*.
- Mettre en place un ensemble *d'incitatifs* pour la prestation des soins de proximité ;
- Mettre en place des espaces et des mécanismes *collaboratifs de dialogue* et de prise de décision;
- Renforcement des capacités : Constituer une masse critique de ressources humaines avec *capacités de pilotage, de négociation et de contractualisation*.

3 I - Les caractéristiques d'un bon système d'information sanitaire sont:

- A. L'ouverture sur tous les intervenants de santé
- B. La conception en mode réseau
- C. Le centrage du stratégique
- D. La centralisation de la gestion du système d'information
- E. L'adaptation aux changements

3 I - Les caractéristiques d'un bon système d'information sanitaire sont:

- A. L'ouverture sur tous les intervenants de santé
- B. La conception en mode réseau
- C. Le centrage du stratégique
- D. La centralisation de la gestion du système d'information
- E. L'adaptation aux changements

Extrait du livre blanc: chantier 8. Un système d'information intelligent

- Ouvrir le SIS à une clientèle élargie.
- Passer à une architecture informatisée en réseau.
- Centrer sur ce qui est stratégique pour gouverner.
- Un dossier individuel et de ménage informatisé, pour assurer la continuité des soins et consolider l'approche médico-économique

32-La lutte contre la mortalité néonatale suppose:

- A. Le renforcement des équipements des structures d'accouchement
- B. La définition des filières de soins en néonatalogie
- C. La documentation de l'état de santé de tout nouveau né sur le carnet de santé de l'enfant
- D. Le renforcement de la consultation postnatale
- E. Le renforcement de la communication autour du plan d'action

32-La lutte contre la mortalité néonatale suppose:

- A. Le renforcement des équipements des structures d'accouchement
- B. La définition des filières de soins en néonatalogie
- C. La documentation de l'état de santé de tout nouveau né sur le carnet de santé de l'enfant
- D. Le renforcement de la consultation postnatale
- E. Le renforcement de la communication autour du plan d'action

Extrait du plan d'action de réduction de la MMN 2012-2016

- Axe d'intervention 1 : Mise à niveau des structures d'accouchement
- Mesure 4 : Définir les filières de soins en néonatalogie, incluant la définition des normes en ressources humaines et équipements pour chaque niveau de prise en charge néonatale ;
- Mesure 13 : Documenter l'état de santé de tout nouveau-né sur le carnet de santé de l'enfant, à rendre disponible au niveau de toute structure d'accouchement ;
- Mesure 23 : Elaborer et mettre en œuvre un plan de communication autour du plan d'action.

33-Les recettes propres des hôpitaux SEGMA proviennent:

- A. Des rémunérations des services rendus à la population
- B. Du produit de ventes des mobiliers et matériels de réforme
- C. De la subvention de l'Etat
- D. Du produit de livraison des poches de sang et dérivés labiles du sang

33-Les recettes propres des hôpitaux SEGMA proviennent:

www.ispits.net

- A. Des rémunérations des services rendus à la population
- B. Du produit de ventes des mobiliers et matériels de réforme
- C. De la subvention de l'Etat
- D. Du produit de livraison des poches de sang et dérivés labiles du sang

34-La planification sanitaire est une tentative consciente de rationaliser l'utilisation des ressources disponibles ou mobilisables pour l'action sanitaire en vue de résoudre des problèmes de santé ou de satisfaire des besoins de santé classés par ordre de priorité

A. Vrai

B. Faux

34-La planification sanitaire est une tentative consciente de rationaliser l'utilisation des ressources disponibles ou mobilisables pour l'action sanitaire en vue de résoudre des problèmes de santé ou de satisfaire des besoins de santé classés par ordre de priorité

A. Vrai

B. Faux

35-Le budget programme est un outil de contractualisation interne:

A. Vrai

B. Faux

35-Le budget programme est un outil de contractualisation interne:

A. Vrai

B. Faux

36-L'assurance sociale est un système de financement de soins , par les contributions, organisé et régulé par la législation. L'assurance sociale implique généralement des conditions obligatoires et des cotisations indexées sur le revenu devant être versées par les employeurs et les employés:

A. Vrai

B. Faux

36-L'assurance sociale est un système de financement de soins , par les contributions, organisé et régulé par la législation. L'assurance sociale implique généralement des conditions obligatoires et des cotisations indexées sur le revenu devant être versées par les employeurs et les employés:

A. Vrai

B. Faux

37-Les hôpitaux publics ne sont pas soumis au contrôle médical exercé par les organismes gestionnaires de l'AMO:

A. Vrai

B. Faux

37-Les hôpitaux publics ne sont pas soumis au contrôle médical exercé par les organismes gestionnaires de l'AMO:

A. Vrai

B. Faux

38-Le suivi d'un programme sert à mesurer les changements sur l'état de santé:

A. Vrai

B. Faux

38-Le suivi d'un programme sert à mesurer les changements sur l'état de santé:

A. Vrai

B. Faux

39-La vision décrit la raison d'être d'une organisation:

A. Vrai

B. Faux

39-La vision décrit la raison d'être d'une organisation:

A. Vrai

B. Faux

La vision décrit une situation future à atteindre

40-La disponibilité caractérise la relation entre les besoins et les couts:

A. Vrai

B. Faux

40-La disponibilité caractérise la relation entre les besoins et les couts:

A. Vrai

B. Faux

41-La mission décrit une situation future à atteindre:

A. Vrai

B. Faux

41-La mission décrit une situation future à atteindre:

A. Vrai

B. Faux

La mission décrit la raison d'être d'une organisation:

42-La disponibilité caractérise la relation entre les besoins et les ressources:

A. Vrai

B. Faux

42-La disponibilité caractérise la relation entre les besoins et les ressources:

A. Vrai

B. Faux

43-VRAIS OU FAUX

- A. L'hôpital de proximité et le CHP sont le premier niveau de référence dans la filière de soins hospitalier.
- B. L'hôpital de proximité comporte 6 disciplines
- C. Le CHP comporte 15 spécialités.
- D. Le CHR est le 3 ère niveau de référence dans la filière de soins hospitalier.
- E. Le CHR comporte 28 spécialités.
- F. Critère de création d'un CHU: Couvrir au moins 2 régions ou une population de plus de 2 Millions hab.
- G. Le CHU comporte 50 spécialités.

43-VRAIS OU FAUX

- A. L'hôpital de proximité et le CHP sont le premier niveau de référence dans la filière de soins hospitalier. **Vrais**
- B. L'hôpital de proximité comporte 6 disciplines. **Faux**
- C. Le CHP comporte 15 spécialités. **Faux**
- D. Le CHR est le 3 ère niveau de référence dans la filière de soins hospitalier. **Faux**
- E. Le CHR comporte 28 spécialités. **Vrais**
- F. Critère de création d'un CHU: Couvrir au moins 2 régions ou une population de plus de 2 Millions hab. **Vrais**
- G. Le CHU comporte 50 spécialités. **Faux**

44-VRAIS OU FAUX

- A. Les hôpitaux érigés en Service de l'Etat Géré de Manière Autonome (SEGMA) disposent de personnalité morale;
- B. les CHU Sont des établissements dotés de personnalité juridique propre,
- C. les SEGMA Sont des établissements dotés d'une indépendance aux autorités administratives
- D. les CHU Sont des établissements dotés d'une autonomie de gestion des ressources.
- E. les SEGMA Sont des établissements dotés d'une autonomie financière plus au moins étendue

44-VRAIS OU FAUX

- A. Les hôpitaux érigés en Service de l'Etat Géré de Manière Autonome (SEGMA) disposent de personnalité morale; **Faux**
- B. les CHU Sont des établissements dotés de personnalité juridique propre, **Vrais**
- C. les SEGMA Sont des établissements dotés d'une indépendance aux autorités administratives **Faux**
- D. les CHU Sont des établissements dotés d'une autonomie de gestion des ressources. **Vrais**
- E. les SEGMA Sont des établissements dotés d'une autonomie financière plus au moins étendue: **Vrais**

45-Parmi les propositions suivantes ayant trait aux mesures d'accompagnement de l'optimisation, la régulation et la maîtrise des dépenses de santé pour assurer la pérennité et la viabilité financière de l'AMO, une est fausse, laquelle :

- A- L'adoption d'une liste des médicaments admis au remboursement
- B- L'adoption d'une liste des ALD fixée par arrêté du MS
- C-La généralisation de la couverture médicale à toutes les catégories socioprofessionnelles
- D- l'organisation par les organismes gestionnaires de l'AMO de services chargés du contrôle médical
- E- La conclusion de conventions de tarification avec les prestataires de soins publics et privés

45-Parmi les propositions suivantes ayant trait aux mesures d'accompagnement de l'optimisation, la régulation et la maîtrise des dépenses de santé pour assurer la pérennité et la viabilité financière de l'AMO, une est fausse, laquelle :

A- L'adoption d'une liste des médicaments admis au remboursement

B- L'adoption d'une liste des ALD fixée par arrêté du MS

C-La généralisation de la couverture médicale à toutes les catégories socioprofessionnelles

D- l'organisation par les organismes gestionnaires de l'AMO de services chargés du contrôle médical

E- La conclusion de conventions de tarification avec les prestataires de soins publics et privés

46-En tant que cadre impliqué dans le processus de régionalisation, la déconcentration signifie :

- A- Délégation de signature, de pouvoirs ou d'attributions du pouvoir central vers les représentants de l'Etat dans un souci d'efficacité et de proximité
- B- Election des représentants de la pop constitue le mode de désignation des responsabilités
- C- Transfert des compétences de l'Etat vers des collectivités publiques (des personnes morales de droit public) dans un souci de démocratie locale et participative
- D- Pouvoir hiérarchique dont l'objectif ultime est le rapprochement de l'administration des citoyens

46-En tant que cadre impliqué dans le processus de régionalisation, la déconcentration signifie :

A- Délégation de signature, de pouvoirs ou d'attributions du pouvoir central vers les représentants de l'Etat dans un souci d'efficacité et de proximité

B- Election des représentants de la pop constitue le mode de désignation des responsabilités

C- Transfert des compétences de l'Etat vers des collectivités publiques (des personnes morales de droit public) dans un souci de démocratie locale et participative

D- Pouvoir hiérarchique dont l'objectif ultime est le rapprochement de l'administration des citoyens

47-Les critères d'allocation des ressources budgétaires aux différentes régions font intervenir:

- A. La production de services (activité sanitaire),
- B. La répartition des infrastructures
- C. La performance des structures sanitaires
- D. La population résidente de chaque région, pondérée par des indicateurs de besoin

47-Les critères d'allocation des ressources budgétaires aux différentes régions font intervenir:

- A. La production de services (activité sanitaire),
- B. La répartition des infrastructures
- C. La performance des structures sanitaires
- D. La population résidente de chaque région, pondérée par des indicateurs de besoin

48-Lequel parmi ces indices de mesure de la gouvernance des systèmes de santé n'est pas retenu par l'OMS :

- A. La mesure de la réactivité du système de santé
- B. La consommation médicale
- C. La mesure de la performance en matière du niveau de santé
- D. L'équité de la contribution au système de santé
- E. Les dépenses de santé/PIB

48-Lequel parmi ces indices de mesure de la gouvernance des systèmes de santé n'est pas retenu par l'OMS :

- A. La mesure de la réactivité du système de santé
- B. La consommation médicale
- C. La mesure de la performance en matière du niveau de santé
- D. L'équité de la contribution au système de santé
- E. Les dépenses de santé/PIB

49- La crise du système de santé est due à:

- A. La détérioration de l'environnement
- B. Le vieillissement de la population
- C. Le ralentissement de l'économie mondiale
- D. La pression sur les finances publiques

49- La crise du système de santé est due à:

- A. La détérioration de l'environnement
- B. Le vieillissement de la population
- C. Le ralentissement de l'économie mondiale
- D. La pression sur les finances publiques

50- En tant que cadre de sante, votre rôle au sein de l'unité de soins est axé sur:

- A. La maintenance et entretien du matériel technique
- B. La planification et administration des soins
- C. L'établissement du programme de formation du personnel médical
- D. La coordination, supervision et évaluation des activités réalisées

50- En tant que cadre de sante, votre rôle au sein de l'unité de soins est axé sur:

- A. La maintenance et entretien du matériel technique
- B. La planification et administration des soins
- C. L'établissement du programme de formation du personnel médical
- D. La coordination, supervision et évaluation des activités réalisées

51 - les éléments suivants expriment la notion d'équité en sante:

- A. Attribuer les biens de sante en fonction des besoins
- B. Minimiser les torts et maximiser les bénéfices
- C. Impartialité
- D. Appliquer le critère de justice formelle

51 - les éléments suivants expriment la notion d'équité en sante:

- A. Attribuer les biens de sante en fonction des besoins
- B. Minimiser les torts et maximiser les bénéfices
- C. Impartialité
- D. Appliquer le critère de justice formelle

52-Cochez la proposition la plus exacte:
la consommation médicale est composée:

www.ispits.net

- A- Des soins hospitaliers et ambulatoires et des biens médicaux
- B- Des soins hospitaliers et ambulatoires ,des biens médicaux et des soins traditionnels
- C. De l'administration générale du système ,la formation, l'enseignement et la recherche.
- D. De la prévention sanitaire, la formation, l'enseignement et la recherche.

52-Cochez la proposition la plus exacte:
la consommation médicale est composée:

- A- Des soins hospitaliers et ambulatoires et des biens médicaux
- B- Des soins hospitaliers et ambulatoires ,des biens médicaux et des soins traditionnels
- C. De l'administration générale du système ,la formation, l'enseignement et la recherche.
- D. De la prévention sanitaire, la formation, l'enseignement et la recherche.

53-Les indicateurs de performance des programmes SMI/PF suivant sont exacts sauf un , lequel?

- A- 3,0 % des enfants dont le poids à la naissance est inférieur à 2,5 kg (2015)
- B- 62,7% des femmes enceintes du milieu rural ont reçu des soins prénatals (2011)
- C-75% des enfants âgés de 12-23 mois ont reçu leur BCG
- D- 72,7% des femmes ont accouchés en milieu surveillé (2011)

53-Les indicateurs de performance des programmes SMI/PF suivant sont exacts sauf un , lequel?

A- 3,0 % des enfants dont le poids à la naissance est inférieur à 2,5 kg (2015)

B- 62,7% des femmes enceintes du milieu rural ont reçu des soins prénatals (2011)

C-75% des enfants âgés de 12-23 mois ont reçu leur BCG

D- 72,7% des femmes ont accouchés en milieu surveillé (2011)

54-Relativement aux taux d'incidence des maladies cibles de la vaccination au Maroc, quel est l'ordre décroissant exact (année 2015) ?

A- Rougeole, tuberculeuse, coqueluche, tétanos

B- Tuberculeuse, Rougeole ,coqueluche, tétanos

C- Tuberculeuse, coqueluche, tétanos, Rougeole

D- Tuberculeuse, Rougeole, tétanos, coqueluche

54-Relativement aux taux d'incidence des maladies cibles de la vaccination au Maroc, quel est l'ordre décroissant exact (année 2015) ?

A- Rougeole, tuberculeuse, coqueluche, tétanos

B- Tuberculeuse, Rougeole ,coqueluche, tétanos

C- Tuberculeuse, coqueluche, tétanos, Rougeole

D- Tuberculeuse, Rougeole, tétanos, coqueluche

55-Selon le rapport de santé en chiffres 2015, l'indice synthétique de fécondité au Maroc est de :

- A- 2,0
- B- 2,19
- C- 2,29
- D- 2,39

55-Selon le rapport de santé en chiffres 2015, l'indice synthétique de fécondité au Maroc est de :

A- 2,0

B- 2,19

C- 2,29

D- 2,39

56- Selon le rapport de santé en chiffres 2015,
l'espérance de vie à la naissance au Maroc :

- A. 75,5 ans
- B. 75,6 ans
- C. 75,7 ans
- D. 75,8 ans

56- Selon le rapport de santé en chiffres 2015,
l'espérance de vie à la naissance au Maroc :

- A. 75,5 ans
- B. 75,6 ans
- C. 75,7 ans
- D. **75,8 ans**

57- Selon le rapport de santé en chiffres 2015, le taux d'occupation moyen des hôpitaux publics est de :

- A. 61,8%
- B. 62,8%
- C. 63,8%
- D. 65,8%

57- Selon le rapport de santé en chiffres 2015, le taux d'occupation moyen des hôpitaux publics est de :

- A. 61,8%
- B. 62,8%
- C. 63,8%
- D. 65,8%

58- Selon le rapport santé en chiffres 2015, la couverture vaccinale globale des enfants âgés de 12 à 23 mois est de (année 2011):

www.ispits.net

- A. 82,5%
- B. 93,5%
- C. 87,7%
- D. 95,5%

58- Selon le rapport santé en chiffres 2015, la couverture vaccinale globale des enfants âgés de 12 à 23 mois est de (année 2011):

- A. 82,5%
- B. 93,5%
- C. 87,7%
- D. 95,5%

59- Selon le rapport santé en chiffres 2015, la durée moyenne des hôpitaux publics est de:

- A. Trois jours
- B. Quatre jours
- C. Cinq jours
- D. Six jours

59- Selon le rapport santé en chiffres 2015, la durée moyenne des hôpitaux publics est de:

- A. Trois jours
- B. Quatre jours
- C. Cinq jours
- D. Six jours

60- En 2015, le budget global du ministère de la santé représente :

- A. 1,1% du produit intérieur brut.
- B. 1,2% du produit intérieur brut.
- C. 1,3% du produit intérieur brut.
- D. 1,4% du produit intérieur brut.

60- En 2015, le budget global du ministère de la santé représente :

- A. 1,1% du produit intérieur brut.
- B. 1,2% du produit intérieur brut.
- C. 1,3% du produit intérieur brut.
- D. 1,4% du produit intérieur brut.

61 - En 2015, le budget global du ministère de la santé représente :

- A. 5,1% du BT de l'Etat.
- B. 5,2% du BT de l'Etat.
- C. 5,3% du BT de l'Etat.
- D. 5,4% du BT de l'Etat.

61 - En 2015, le budget global du ministère de la santé représente :

- A. 5,1% du BT de l'Etat.
- B. 5,2% du BT de l'Etat.
- C. **5,3% du BT de l'Etat. (6%BF, 2,8BI)**
- D. 5,4% du BT de l'Etat.

62-En 2011, le taux de mortalité infantile (pour 1000 naissances) est de:

- A. 27,8%°
- B. 28,8 %°
- C. 30,5 %°
- D. 30,8 %°

62-En 2011, le taux de mortalité infantile (pour 1000 naissances) est de:

- A. 27,8%°
- B. 28,8 %°
- C. 30,5 %°
- D. 30,8 %°

www.ispits.net

63-En 2015, la desserte globale en ESSP est de:

- A. 1 établissement pour 11 226 habitants
- B. 1 établissement pour 12 226 habitants
- C. 1 établissement pour 13 226 habitants
- D. 1 établissement pour 14 226 habitants

63-En 2015, la desserte globale en ESSP est de:

- A. 1 établissement pour 11 226 habitants
- B. 1 établissement pour 12 226 habitants
- C. 1 établissement pour 13 226 habitants
- D. 1 établissement pour 14 226 habitants

64-En 2015, la densité litière publique est de :

- A. 1 lit pour 1 151 habitants
- B. 1 lit pour 1 251 habitants
- C. 1 lit pour 1 351 habitants
- D. 1 lit pour 1 551 habitants

64-En 2015, la densité litière publique est de :

- A. 1 lit pour 1 151 habitants
- B. 1 lit pour 1 251 habitants
- C. 1 lit pour 1 351 habitants
- D. 1 lit pour 1 551 habitants

65-En 2013, le nombre d'habitants par médecin pour l'ensemble des secteurs est:

- A. 1 025 habitants/médecin
- B. 1 525 habitants/médecin
- C. 1 925 habitants/médecin
- D. 2 025 habitants/médecin

65-En 2013, le nombre d'habitants par médecin pour l'ensemble des secteurs est:

- A. 1 025 habitants/médecin
- B. 1 525 habitants/médecin
- C. 1 925 habitants/médecin
- D. 2 025 habitants/médecin

66-En 2013, le nombre d'habitants par infirmier du secteur public est de:

- A. 839
- B. 1139
- C. 1339
- D. 1439

66-En 2013, le nombre d'habitants par infirmier du secteur public est de:

- A. 839
- B. 1139
- C. 1339
- D. 1439

67- Classer par ordre décroissant les Principales causes de mortalité au Maroc (année 2014):

- A. Tumeurs
- B. Maladies de l'appareil circulatoire
- C. Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques
- D. Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale

67- Classer par ordre décroissant les Principales causes de mortalité au Maroc (année 2014):

A. Tumeurs

B. Maladies de l'appareil circulatoire

C. Maladies endocriniennes,
nutritionnelles et métaboliques

D. Certaines affections dont l'origine se
situe dans la période périnatale

Rép: 1-B, 2-A, 3-D, 4-C

68- En 2015, le taux d'incidence de la tuberculose au Maroc est de:

- A. 83,6 pour 100.000 habitants
- B. 84,6 pour 100.000 habitants
- C. 85,6 pour 100.000 habitants
- D. 87,6 pour 100.000 habitants

68- En 2015, le taux d'incidence de la tuberculose au Maroc est de:

- A. 83,6 pour 100.000 habitants
- B. 84,6 pour 100.000 habitants
- C. 85,6 pour 100.000 habitants
- D. 87,6 pour 100.000 habitants

69- En 2015, le nombre des consultations paramédicales par habitants dans les ESSP marocains en milieu rural est de:

- A. 0,7 consultation par habitant
- B. 0,8 consultation par habitant
- C. 0,9 consultation par habitant
- D. 1 consultation par habitant

www.ispits.net

69- En 2015, le nombre des consultations paramédicales par habitants dans les ESSP marocains en **milieu rural** est de:

- A. 0,7 consultation par habitant
- B. 0,8 consultation par habitant
- C. 0,9 consultation par habitant
- D. 1 consultation par habitant

70-Le suivi d'un programme sert à mesurer le changement sur l'état de santé:

- A. Vrai
- B. Faux

70-Le suivi d'un programme sert à mesurer le changement sur l'état de santé:

- A. Vrai
- B. Faux

71 - L'accréditation des établissements de santé vise l'accroissement des recettes:

- A. Vrai
- B. Faux

71 - L'accréditation des établissements de santé vise l'accroissement des recettes:

A. Vrai

B. Faux

72- Les mesures de la performance en matière de niveau de santé comparent les niveaux de santé atteints et ceux qui pourraient l'être par le système de santé le plus performant:

A. Vrai

B. Faux

72- Les mesures de la performance en matière de niveau de santé comparent les niveaux de santé atteints et ceux qui pourraient l'être par le système de santé le plus performant:

A. Vrai

B. Faux

73- La mesure de la réactivité des systèmes de santé porte entre autres sur l'attention accordée au patient en ce qui a trait à la rapidité de la PEC , la qualité de l'environnement, l'accès au réseau d'aide sociale et choix du prestataire:

A. Vrai

B. Faux

73- La mesure de la réactivité des systèmes de santé porte entre autres sur l'attention accordée au patient en ce qui a trait à la rapidité de la PEC , la qualité de l'environnement, l'accès au réseau d'aide sociale et choix du prestataire:

A. Vrai

B. Faux

74-L'évaluation consiste à mesurer le niveau de réalisation d'objectifs déterminés préalablement à l'action:

- A. Vrai
- B. Faux

74-L'évaluation consiste à mesurer le niveau de réalisation d'objectifs déterminés préalablement à l'action:

- A. Vrai
- B. Faux

75-Le leadership d'un individu est, au sein d'un groupe, la relation de confiance qui s'établit entre cet individu et la majorité des membres de ce groupe dans la poursuite d'un objectif partagé

- A. Vrai
- B. Faux

75-Le leadership d'un individu est, au sein d'un groupe, la relation de confiance qui s'établit entre cet individu et la majorité des membres de ce groupe dans la poursuite d'un objectif partagé

- A. Vrai
- B. Faux

76-Le management opérationnel consiste à :

- A. Assurer la gestion de l'établissement
- B. Animer les équipes
- C. Définir les prévisions
- D. Organiser le travail

76-Le management opérationnel consiste à :

- A. Assurer la gestion de l'établissement
- B. Animer les équipes
- C. Définir les prévisions
- D. Organiser le travail

www.ispits.net

77-Pour planifier les prestations de soins, les principales sources d'information sont :

- A. La personne soignée
- B. Les enquêtes
- C. Les archives
- D. Le dossier du patient

77-Pour planifier les prestations de soins, les principales sources d'information sont :

- A. La personne soignée
- B. Les enquêtes
- C. Les archives?????
- D. Le dossier du patient

78-Les avantages de l'utilisation des protocoles de soins sont essentiellement:

- A. Favoriser l'efficacité par l'uniformisation des soins
- B. Participer au développement www.ispits.net du caractère scientifique des soins
- C. Apporter une contribution à la qualité des soins
- D. Maximiser les recettes de l'hôpital

78-Les avantages de l'utilisation des protocoles de soins sont essentiellement:

- A. Favoriser l'efficacité par l'uniformisation des soins
- B. Participer au développement du caractère scientifique des soins
- C. Apporter une contribution à la qualité des soins
- D. Maximiser les recettes de l'hôpital

79-La formation et le développement des compétences procurent au gestionnaire de l'us:

- A. Une capacité de contrôler l'équipe de soins et d'administrer des mesures disciplinaires
- B. Une adaptation permanente vis-à-vis de son environnement
- C. Une motivation pour l'accompagnement de l'équipe de soins
- D. Un engagement pour la réalisation des projets de recherche en soins

79-La formation et le développement des compétences procurent au gestionnaire de l'us:

- A. Une capacité de contrôler l'équipe de soins et d'administrer des mesures disciplinaires
- B. Une adaptation permanente vis-à-vis de son environnement
- C. Une motivation pour l'accompagnement de l'équipe de soins
- D. Un engagement pour la réalisation des projets de recherche en soins

80-L'estimation des besoins en médicaments par la méthode fondée sur la morbidité pour un service X nécessite:

- A. De connaître la consommation mensuelle moyenne.
- B. Les schémas type de traitement pour chaque pathologie.
- C. Le coût global par pathologie traitée au service.
- D. Le nombre de cas par pathologies traitées au service pour une période donnée.

80-L'estimation des besoins en médicaments par la méthode fondée sur la morbidité pour un service X nécessite:

- A. De connaître la consommation mensuelle moyenne.
- B. Les schémas type de traitement pour chaque pathologie.
- C. Le coût global par pathologie traitée au service.
- D. Le nombre de cas par pathologies traitées au service pour une période donnée.

Méthode morbidité - Principe -

10

- Nécessite :
 - Liste des *pathologies* traitées par service (CIM)
 - *Nombre de cas* par pathologie par année
 - *Schémas types de traitement* pour chaque pathologie (consensus)
- Formule de calcul :

<i>Quantité totale nécessaire pour traiter une pathologie</i>	<i>=</i>	<i>Quantité de médicaments pour un traitement type</i>	<i>X</i>	<i>Nombre d'épisodes de traitement de la pathologie</i>
---	----------	--	----------	---

Méthode consommation - Principe -

15

- Evaluation des besoins sur la base de **l'utilisation réelle antérieure** des produits
- Formules de calcul :

$$\begin{array}{ccccccc} \text{Consommation} & = & \text{Stock} & + & \text{Produits} & - & \text{Stock} \\ \text{Mensuelle} & & \text{Initial} & & \text{reçus} & & \text{final} \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} \text{Consommation} & & \text{Consommation de N mois} \\ \text{Mensuelle Moyenne} & = & \text{-----} \\ \text{(CMM)} & & \text{N mois} \end{array}$$

A word cloud featuring various expressions of gratitude in multiple languages. The words are arranged in a circular pattern, with the most prominent words in the center. The languages include English, French, Spanish, Italian, German, Japanese, Korean, and many others. The words are color-coded, with red, blue, green, and purple being the most common colors.

Key words visible include:

- merci
- thank you
- gracias
- obrigado
- danke
- arigatō
- ngiyabonga
- moachakkeram
- terima kasih
- kasih
- gratias
- agat
- maith
- raibh
- go
- sobodi
- dankon
- manana
- murakoze
- spas
- teşekkür ederim
- dhanyavad
- shukriya
- diolch
- merci
- grazzi
- merci
- tanemirt
- dekuji
- bayaralaa
- kia ora
- ありがとう
- bedanki
- tau
- barka
- aciü
- akun
- subay
- lack
- dakujem
- mochchakkeram
- mamnun
- তোমাকে ধন্যবাদ
- kop khun
- najis tuke
- paldies
- faafetai lava
- kam sah hamnida
- nanni
- taiku
- asante
- tesekkur ederim
- hvala
- koszom
- blagodar
- rahmet
- kop khun
- krap
- mercé
- leat
- nandri
- mahalo
- didi madloba
- griez
- Баярлалаа
- vinaka
- euχαριστώ
- mauruuru
- dankie
- kiitos
- chokrane
- sagolun
- matondo
- dhanyavadagalu
- efnkykuzo
- dziękuję
- tenki
- takk
- tapadh
- krap
- gracie
- mes
- welalin
- gracies
- misaoira
- gratias ago
- elkosi
- chhorakalutuum
- dank je
- chhorakalutuum